

○ 細胞性免疫低下時に播種性真菌症となって他臓器に播種した場合に、敗血症や肺炎・髄膜炎などとともに ARDS を合併することがある。

× イベルメクチンが第一選択薬である。

○

1

× 以前は原虫と考えられていたが、ゲノム解析により真菌に分類されるようになった。

○ 飛沫感染が主であり、無症候者でも保菌している場合がある。

× HIV 患者では亜急性の経過をたどるのに対し、非 HIV 患者では 1 週間程度で急激に進行し、炎症が強く、死亡率 30～60% と高い。

× 両側びまん性すりガラス影が典型的だが、浸潤影や結節・空洞影、気胸などを呈することがある。

○ 培養検査では検出できない。

× Grocott 染色に比べると感度が高いとされるが、判定には熟練を要する。

○ WAKO 法では HIV 患者で 23.2 pg/mL、非 HIV 患者で 31.1 pg/mL がカットオフ値として提唱されている。

○ 軽症ではアトバコンでも治療可能である。

○ 主に HIV 患者でのエビデンスだが、 PaO_2 70 Torr 未満あるいは肺泡気-動脈血酸素分圧較差 35 Torr 以上の重症例では副腎皮質ステロイド投与が推奨される。

× 亜急性～慢性の経過をとるのは細胞性免疫不全である。好中球減少症や液性免疫不全は急性の経過で敗血症などの重症感染症を起こす。